



질병관리청

보 도 참 고 자 료

다시, 대한민국!
새로운 국민의 나라

보도 일시	2022. 7. 7.(목) 11:00	배포 일시	2022. 7. 7.(목) 11:00
담당 부서	중앙방역대책본부 위기소통팀	책임자	팀 장 고재영 (043-719-9381)
		담당자	사무관 김남혁 (043-719-9344)

중증·사망 예방을 위해 고령층 포함 접종 대상자에 예방접종 당부

주요 내용

□ 코로나19 예방접종 추진 현황

- (60세 이상 4차접종) 인구 대비 31.4%, 6월 말 기준 대상자 대비 35.3%
- (3차접종) 전체 인구 대비 65.0%, 6월 말 기준 대상자 대비 74.9%

□ 60세 이상 연령층 4차접종 시행

- 중증·사망 예방 및 오미크론 유행 지속, 신규 변이 바이러스 유행 등 불확실성을 고려하여 4차접종 시행, 특히 80세 이상 적극 권고
- 고령층을 비롯한 아직 접종하지 않은 분들의 관심과 참여 당부

- 코로나19 예방접종대응추진단(단장 백경란 청장, 이하 추진단)에 따르면, **차수별 인구 대비 접종률은 1차접종 87.8%(4,507만 명), 2차접종 87.0%(4,463만 명, 얀센 백신 1회 접종자 포함), 3차접종 65.0%(3,338만 명), 4차접종 8.7%(448만 명)**이다.

- **(4차접종)** 60세 이상을 대상으로 실시하되, 80세 이상 연령층에게 적극 권고하고 있다.
- 6월 말 기준, 60세 이상 연령층의 대상자(접종간격 도래자, 1,225만 명) 대비 접종률은 35.3%이며, 80세 이상의 대상자 대비 접종률은 55.2%로 높게 나타나고 있다.

○ 연령대별 대상자 대비 접종률은 80대 이상(55.2%)이 가장 높았고, 70대 (45.6%), 60대(23.6%) 순으로 나타났다.

- 7월 1일부터 대상자 집계 시점이 7월 말로 변경됨에 따라 접종대상자 추가(1,225만 명, 6월 말 기준 대비 +9.8만 명)로 인해 대상자 대비 접종률이 소폭 감소*하였다.

* 6.30. 0시 기준 60세 이상 대상자 대비 접종률 35.1% → 7.1. 0시 기준 34.9%

□ **(3차접종)** 12세 이상을 대상으로 실시하며, 18세 이상 성인과 12~17세 청소년 중 고위험군에게 적극 권고하고 있다.

○ 6월 말 기준, 대상자(접종간격 도래자, 4,456만 명) 대비 접종률은 74.9%이며, 60세 이상의 대상자 대비 접종률은 93.7%로 높게 나타나고 있다.

○ 청소년(12~17세, `10년생 중 생일이 지난 사람~`05년생)은 현재까지 총 28.3만 명이 3차접종에 참여(대상자 대비 15.7%)하였다.

□ **(기초접종)** 5세 이상을 대상으로 실시하며, 12세 이상 전체와 5~11세 소아 중 고위험군에게 적극 권고하고 있다.

○ 18세 이상 성인의 기초접종률은 96%를 초과하여 매우 높으며, 12~17세(`05~`10년생) 청소년의 기초접종률 또한 66%를 초과하였다.

○ 5~11세(`17년생 중 생일이 지난 사람~`10년생 중 생일이 지나지 않은 사람) 소아 중 6.0만 명이 1차접종에 참여하였으며, 4.0만 명이 2차접종을 완료하였다.

□ **코로나19 예방접종 대응추진단**(단장 백경란 청장, 이하 '추진단')은 60세 이상 연령층에 대한 4차접종의 중요성을 강조하였다.

○ 최근 4주간(`22.5.29.~6.25.) 위중증 환자의 83%, 사망자의 85%가 60세 이상 연령층에 집중되어 있고, 특히 사망자 중 80세 이상이 54.6%를 차지하고 있어, 추가적인 접종을 통한 중증·사망 예방 필요성이 커지고 있다.

○ 최근 60세 이상 장기요양시설 거주자를 대상으로 수행한 이스라엘의 연구¹⁾에서, 3차접종군 대비 4차접종군의 중증예방효과는 67%(95% CI, 57%-75%), 사망예방효과는 72%(95% CI, 57%~83%)로 분석되었다.

- 위 연구 결과는 오미크론 변이 유행에도, 4차접종(화이자)이 장기요양 시설 거주자의 중증·사망 위험을 낮췄음을 시사한다.

1) Association of Receipt of the Fourth BNT162b2 Dose With Omicron Infection and COVID-19 Hospitalizations Among Residents of Long-term Care Facilities (JAMA Intern Med, '22.6.23)

□ 60세 이상 연령층의 4차접종은 위중증·사망 예방을 목표로 하며, 특히 치명률이 높은 80세 이상에 대해서는 적극 권고한다.

○ 3차접종 후 최소 4개월(120일) 경과 시점부터 접종할 수 있고, mRNA 백신으로 접종받게 되나, 노바백스 백신으로도 접종 가능하다.

○ 사전예약 누리집(ncvr.kdca.go.kr)을 통해 예약하거나 당일접종으로 접종 가능하고, 스스로 예약이 어려운 고령층은 누리집을 통한 대리예약이나, 전화예약(1339, 지자체콜센터)도 할 수 있다.

○ 현재까지 60세 이상 연령층 중 약 432만 명이 4차접종을 완료하여 접종률은 31.4%로 집계되었으며, 대상자 대비 접종률은 35.3%이다.

- 특히, 치명률이 높아 접종이 적극 권고되는 80세 이상의 대상자 절반 이상이 접종에 참여하여(대상자 대비 접종률 55.2%) 높게 나타났다.

【60세 이상 4차접종 현황(7.7. 0시 기준)】

(단위 : 명, %)

구분	인구 ¹⁾ (A)	대상자 ²⁾ (B)	예약자	예약률		접종자	접종률	
				인구 대비(C/A)	대상자 대비(C/B)		인구 대비(D/A)	대상자 대비(D/B)
60세 이상 계	13,743,932	12,252,803	4,487,682	32.7	36.6	4,320,615	31.4	35.3
80대 이상	2,455,738	2,063,956	1,172,828	47.8	56.8	1,138,694	46.4	55.2
70-79세	3,883,747	3,552,843	1,673,907	43.1	47.1	1,618,602	41.7	45.6
60-69세	7,404,447	6,636,004	1,640,947	22.2	24.7	1,563,319	21.1	23.6

1) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)

2) '22. 7. 31일 기준 접종대상자(대상군별 접종간격은 상이)

□ 추진단은 오미크론 변이의 유행에도 코로나19 백신 접종은 본인과 가족의 건강을 지키기 위한 가장 효과적이고 중요한 수단인 점을 재차 강조하며,

○ 특히, 중증·사망 예방을 위해 고령층을 비롯하여 아직 접종하지 않은 분들의 관심과 참여를 당부했다.

□ 정부는 지난해부터 코로나19 백신의 충분한 확보를 통해 국내 예방접종을 차질없이 실시하고자 백신 수급을 적극적으로 추진해 왔다.

○ 현재까지 올해 확보한 백신 1억 6천만회분 중 약 2천7백만회분이 도입되었고, 작년에 이월된 물량과 함께 국내 예방접종에 활용하여 현재까지 약 1천8백만회분이 남아있는 상황이다.

□ 이에, 우리나라가 확보한 백신의 활용도를 제고하기 위하여 5월부터 질병청, 복지부, 외교부, 행안부 등 관계부처로 구성된 범부처 TF를 구성하여 공급 일정 조정 등 다양한 방안을 논의해 왔으며, 일부 성과를 거두었다.

□ 우선, 지난해 모더나 백신을 600만 회분 축소 계약했던 것과 마찬가지로, 올해는 얀센 백신과 코백스에 대하여 공급 물량을 축소기로 협의하였다.

○ 얀센 백신의 경우 물량을 400만 회분 축소 계약하여 추가적인 공급은 없을 예정이다.

○ 코백스를 통해 구매한 2천만회분에 대해서도, 그간 도입된 252만회분과 지난해 8월 이미 배정을 받았던 아스트라제네카 483만 회분을 제외한 1,265만회분에 대해서는 추가 도입하지 않기로 합의하고 환불 절차를 진행키로 하였다.

□ 화이자 백신에 대해서는, 공급 일정을 조정하여 추가적인 예방접종이 진행되지 않는 3분기에는 백신이 공급되지 않도록 협의하였으며, 모더나 백신에 대해서도 공급 일정 조정을 협의하고 있다.

○ 또한, 노바백스의 경우 공급기한을 내년 말까지로 조정하고, SK바이오사이언스 국산백신은 24년 6월까지로 계약하여 국내 접종수요를 감안하여 상황에 따라 공급 시기를 협의하기로 하였다.

- 아울러, 현재 새로운 변이바이러스를 대상으로 mRNA 백신 개발이 진행 중인 바, 개량백신이 출시될 경우 우리나라의 수요에 따라 신속히 공급될 수 있도록 개발 단계에서부터 제약사와 지속적인 협의 진행하고 있다.
- 우리나라는 지난 해부터 전 세계적 백신의 공평한 접근을 위하여 중저소득국의 코로나19 예방 접종 확대를 지원하여 왔으며, 올해에도 추가적으로 백신을 필요로 하는 국가에 대한 지원 방안을 모색하였다.
 - 가이아나와 멕시코의 팬데믹 극복을 위해 각각 모더나 4만회분, 화이자 80만회분을 지원하기로 하였으며, 향후 백신을 필요로 하는 다른 국가에도 지속 지원을 검토해 나갈 예정이다.
- 앞으로도 제약사와의 추가적 협의를 포함하여 국내·외적으로 백신을 최대한 활용할 수 있는 방안을 모색해 나갈 예정이다.

【 '22년 백신 도입 현황 및 계획 ('22.7.7. 기준, 단위: 회분) 】

백신 종류	확보 물량	도입 완료			물량감축	도입 예정**
		계	1분기	2분기		
계	1억 6,044만	2,694만	1,496만	1,198만	1,665만	약 1억 1,685만
화이자	6,000만	1,903.1만*	892.9만	1,010.2만		
모더나	2,847만	508.2만	399.8만	108.4만		
노바백스	4,000만	233.5만	203.1만	30.4만		
얀센	449만	49.2만	-	49.2만	400만	
코백스	1,748만	-	-	-	1,265만	
SK바이오사이언스	1,000만	-	-	-		

* 소아용 백신 133.7만 회분 포함(1분기 30만, 2분기 103.7만)

** 백신 공급 일정 및 물량 관련 제약사와 협의중

- 추진단은 코로나19 예방접종 시작 이후 현재까지 신고된 이상반응 의심사례에 대한 주간(70주차, 7.3. 0시 기준) 분석 결과를 발표했다.
 - * 이상반응 신고통계는 '만 나이' 기준 예방접종 건수를 기반으로 산출 (인구집단을 기반으로 산출하는 예방접종현황의 예방접종 건수와 다름)
- 전체 예방접종 125,309,520건 중 이상반응은 472,321건(0.38%)이 신고되었으며, 일반 이상반응은 453,630건(96.0%), 중대한 이상반응은 18,691건(4.0%)이었다.
 - * 일반 이상반응은 주사부위의 통증, 발적 등 국소이상반응과 발열, 근육통 등 전신이상반응, 중대한 이상반응은 중증, 사망, 아나필락시스 및 주요 이상반응
 - ※ 69주~70주 동안 신고된 의심 이상반응은 546건
 - 백신별 이상반응은 아스트라제네카 백신 109,900건(0.54%), 화이자 백신 240,971건(0.31%), 모더나 백신 111,723건(0.45%), 얀센 백신 8,859건(0.59%), 노바백스 백신 868건(0.15%)이었다.
 - 접종 차수별 이상반응은 기초접종(1·2차접종) 415,040건(0.47%), 3차접종 54,549건(0.16%), 4차접종 2,732건(0.06%)이었다.
 - 5~18세 소아·청소년 예방접종 6,687,240건 중 이상반응은 21,083건(0.32%)이 신고되었고, 신고사례 중 일반 이상반응은 20,461건(97.0%), 중대한 이상반응은 622건(3.0%)이었다.
- 추진단은 안전한 예방접종을 위해 코로나19 백신 접종 이후 발생할 수 있는 이상반응에 대한 주의를 당부하였다.
- 접종받는 사람은 예방접종 이후 15~30분간 접종기관에 머물러 이상반응 발생 여부를 관찰하고, 귀가 후에도 적어도 3시간 이상 주의 깊게 관찰해야 하며, 접종 이후 최소 3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰하고, 고열이 있거나 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 의사 진료를 받도록 해야 한다.

- 특히, **중증 알레르기 반응(아나필락시스)**이 나타나면 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원해야 한다.

○ 화이자, 모더나 백신 접종 이후 다음과 같은 심근염/심낭염 의심증상이 나타나면 신속히 의료기관 진료를 받도록 당부했다.

【심근염 및 심낭염 의심증상】

- ◆ 예방접종 이후 아래와 같은 증상이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ① 가슴 통증, 압박감, 불편감 | ② 호흡곤란 또는 숨가쁨, 호흡시 통증 |
| ③ 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림 | ④ 실신 |

○ 특히, 예방접종 이후 이상반응 의심 환자를 진료한 의료기관은 심근염, 심낭염 등 신속한 진단·치료 및 예방접종 이후 이상반응 신고를 철저히 해줄 것을 당부하였다.

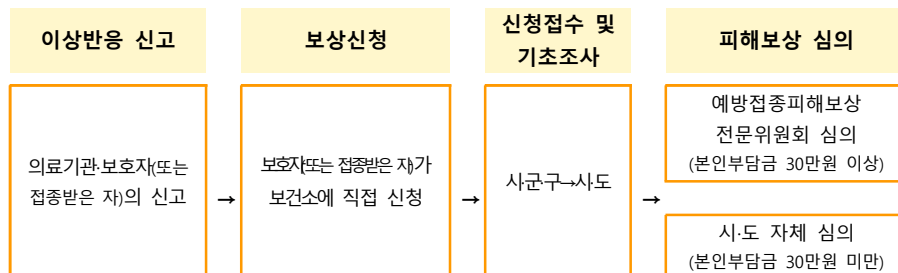
□ 아울러, 이상반응 신고만으로 피해보상 절차가 진행되지는 않으므로, 피해보상을 신청하고자 하는 경우는 의사 등이 이상반응을 신고한 이후 접종받은 자(또는 보호자)가 필요서류를 구비하여 관할 보건소로 신청하여야 함을 강조하였다.

○ 현재, 코로나19 예방접종 피해보상 신청 절차* 및 필요서류** 목록은 코로나19 예방접종 누리집에 게재하였으며, 질병관리청 콜센터(국번없이 1339)를 통해서도 관련 내용을 안내받을 수 있다.

* 코로나19 예방접종 누리집(ncv.kdca.go.kr)의 [이상반응]-[코로나19 예방접종피해 보상신청]

** 코로나19 예방접종 누리집(ncv.kdca.go.kr)의 [알림·서식]-[서식]의 신청양식 참조

[코로나19 예방접종 이후 국가 피해보상 절차]



- <붙임> 1. 코로나19 예방접종 이후 이상반응 주간 분석 결과(70주차)
2. 국외 코로나19 예방접종 이후 이상반응 보고 현황(70주차)
3. 인과성 인정 및 관련성 질환 기준
4. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)

붙임 1 코로나19 예방접종 이후 이상반응 분석 결과(70주차)

< 일 러 두 기 >

- ◆ 2021년 2월 26일부터 2022년 7월 3일(70주차) 0시까지 코로나19 예방접종 이후 **이상 반응**으로 의심되어 신고된 자료임
* 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 의료인이 이상반응 의심사례 신고
- ◆ **이상반응(Adverse event)**은 백신 접종후 발생한 바람직하지 않고 의도되지 아니한 **징후, 증상 또는 질병을 말하며 당해 백신과 인과관계가 가져야 하는 것을 아님** 즉, 이 보고서의 이상반응은 진단의 적합성 또는 백신과의 인과성을 입증한 자료는 아님
- ◆ 이상반응 의심사례는 신고 당시 환자 상태를 기준으로 ‘일반 이상반응’과 ‘중대한 이상반응(사망, 주요 이상반응)’으로 분류함
- 중대한 이상반응은 사망, 주요 이상반응*
* 주요 이상반응: 중증 이상반응(중환자실 입원, 생명위중, 영구장애/후유증)과 특별관심 이상반응(혈소판 감소성 혈전증, 길랑바레 증후군, 아나필락시스 등) 포함
- 일반 이상반응은 중대한 이상반응 외의 이상반응
- ◆ 코로나19 백신 종류는 ①아스트라제네카사의 백신제브리아주(이하 ‘아스트라제네카’), ②화이자-바이오엔텍사의 코미나티주(토지나메란)(이하 ‘화이자’), ③존슨앤존슨사의 코비드-19 백신얀센주(이하 ‘얀센’), ④모더나사의 스파이크박스(이하 ‘모더나’), ⑤노바백스사의 뉴백소비드프리필드시린지(이하 ‘노바백스’)를 포함
- ◆ “신고율”은 코로나19 예방접종 1,000 건당 신고 건수 또는 10만 건당 신고 건수로 산출
* (산출식) 예방접종 후 이상반응 의심사례 신고(건) / 코로나19 예방접종(건) × (1,000 또는 100,000)
- 신고율은 접종연령이나 백신에 대한 인식 등 다양한 요인의 영향을 받으므로, 백신별 신고율의 직접적 비교는 어려움
- ◆ “연령” 구분은 접종일 당시 ‘만나이’ 기준으로 산출
- ◆ 국외기관 접종건, 기타백신(아스트라제네카, 화이자, 얀센, 모더나, 노바백스 이외 백신) 접종건은 포함되지 않음
- ◆ 이상반응 신고현황 통계의 예방접종현황은 '21.2.26. 이후 누적 예방접종 건수와 예방접종 당시의 연령을 반영한 것으로, 예방접종현황 표의 예방접종 건수와 다름
- ◆ 심근염 및 심낭염 분석사례는 진단적합성 평가결과이며 **인과성을 의미하지 않음**
- ◆ 코로나19 예방접종 이후 신고된 중증(사망) 및 특별관심 이상반응 사례에 대해 피해조사반 검토 결과(1~65차)이며 **백신과의 인과성이 확정된 것을 의미하지 않음**

질병관리청은 코로나19 예방접종 이후 의심되는 이상반응을 신고해 주신 모든 분께 감사드립니다.

1. 요약

- (예방접종 현황) 70주차까지 **코로나19 예방접종 125,465,285건** 시행
- 화이자 백신 62.5%, 모더나 백신 19.6%, 아스트라제네카 백신 16.2%, 얀센 백신 1.2%, 노바백스 백신 0.5%
- (이상반응 신고현황) 70주차까지 코로나19 예방접종 이후 의심되는 **이상반응 472,321건** 신고 받음
- **일반 이상반응 96.0%**(453,630건), **주요 이상반응 3.6%**(16,996건), **사망 0.4%**(1,695건)
- 이상반응 신고율은 백신 1,000건 접종시 3.76건으로, 백신별 얀센 5.87건, 아스트라제네카 5.40건, 모더나 4.54건, 화이자 3.07건, 노바백스 1.51건
- 일반이상반응 신고율은 백신 1,000건 접종시 3.62건, 주요 이상반응 0.14건, 사망 0.01건

[표 1. 코로나19 예방접종 및 이상반응 신고 현황]

- (이상반응 증상발생까지 소요일) 70주차까지 코로나19 예방접종 이후 이상반응 최초 증상발생까지 평균 소요일은 4.93(4.90~4.96)일

2. 일반 현황

□ 총괄

- (전체) 70주차까지 코로나19 예방접종 이후 이상반응 신고율(1,000건 접종)은 3.76건
 - (성별) 여자 4.76건, 남자 2.74건으로 여성의 신고가 높음
 - (연령대별) 30-39세 4.91건으로 가장 높고, 80세이상 2.01건으로 가장 낮음
 - (백신별) 얀센 5.87건, 아스트라제네카 5.40건, 모더나 4.54건, 화이자 3.07건, 노바백스 1.51건 순
 - (접종차수별) 1차 5.36건, 2차 4.08건, 3차 1.64건, 4차 0.61건 순
 - (중증도별) 일반 이상반응 3.62건, 주요 이상반응 0.14건, 사망 0.01건

[표 2. 코로나19 예방접종 이후 이상반응 신고 현황]

(단위: 건(%))

구분		이상반응	신고율(건/1,000건 접종)
전체		472,321 (100.0)	3.76
성별	남	170,265 (274.3)	2.74
	여	302,056 (476.5)	4.76
연령대별	19세이하	26,278 (329.2)	3.29
	20-29세	80,909 (477.7)	4.78
	30-39세	77,700 (490.9)	4.91
	40-49세	79,429 (381.7)	3.82
	50-59세	82,119 (342.4)	3.42
	60-69세	78,645 (365.5)	3.66
	70-79세	34,573 (285.6)	2.86
	80세이상	12,668 (200.9)	2.01
백신별	아스트라제네카	109,900 (540.1)	5.40
	화이자	240,971 (307.3)	3.07
	모더나	111,723 (453.7)	4.54
	얀센	8,859 (587.0)	5.87
	노바백스	868 (150.8)	1.51
접종차수별	1차	240,086 (535.6)	5.36
	2차	174,954 (407.9)	4.08
	3차	54,549 (163.8)	1.64
	4차	2,732 (61.5)	0.61
중증도별	일반 이상반응	453,630 (96.0)	3.62
	중대한 이상반응	18,691 (4.0)	0.15
	주요 이상반응	16,996 (3.6)	0.14
	사망	1,695 (0.4)	0.01

- (신고율 추이) 코로나19 예방접종 이후 이상반응 의심 사례 신고율(1,000건 접종)은 접종 시행 초기인 1주차(21년 10주)에 18.5건에서 70주차(22년 26주)에 0.3건으로 지속 감소 추세

[그림 1. 이상반응 신고율 추이(접종일 기준)]

□ 이상반응 중증도별 신고현황

- (전체) 70주차까지 코로나19 예방접종 125,465,285건 시행, 이상반응 의심사례로 472,321건 신고되어, 이상반응 신고율(1,000건 접종)은 3.76건
- (성별) 여자 4.76건, 남자 2.74건으로 여자가 약 1.7배 높음
- (연령대별) 20~30대에서 높고, 80세 이상에서 신고율이 낮음
 - * 30~39세(4.91건), 20~29세(4.78건), 40~49세(3.82건), 60~69세(3.66건), 50~59세 (3.42건), 19세 이하(3.29건), 70~79세(2.86건), 80세 이상(2.01건) 순
- (백신별) 얀센 5.87건, 아스트라제네카 5.40건, 모더나 4.54건, 화이자 3.07건, 노바백스 1.51건 순
- (접종차수별) 1차 5.36건, 2차 4.08건, 3차 1.64건, 4차 0.61건 순

[표 3. 코로나19 예방접종 이후 중증도별 이상반응 신고현황]

(단위: 건/1,000건 접종)

구 분		예방접종 ^중	이상반응 ^a				
			전 체	일반 이상반응 ^b	중대 한 이상반응 ^c		
		소 계			사 망	주요 이상반응	
전 체		125,465,285	472,321 (3.76)	453,630 (3.62)	18,691 (0.15)	1,695 (0.01)	16,996 (0.14)
성 별	남	62,074,306	170,265 (2.74)	161,619 (2.60)	8,646 (0.14)	1,084 (0.02)	7,562 (0.12)
	여	63,390,979	302,056 (4.76)	292,011 (4.61)	10,045 (0.16)	611 (0.01)	9,434 (0.15)
연 령 대 별	19세이하	7,982,718	26,278 (3.29)	25,514 (3.20)	764 (0.10)	10 (0.00)	754 (0.09)
	20~29세	16,937,413	80,909 (4.78)	78,960 (4.66)	1,949 (0.12)	40 (0.00)	1,909 (0.11)
	30~39세	15,828,739	77,700 (4.91)	75,452 (4.77)	2,248 (0.14)	79 (0.00)	2,169 (0.14)
	40~49세	20,807,363	79,429 (3.82)	76,874 (3.69)	2,555 (0.12)	133 (0.01)	2,422 (0.12)
	50~59세	23,981,943	82,119 (3.42)	79,126 (3.30)	2,993 (0.12)	247 (0.01)	2,746 (0.11)
	60~69세	21,516,260	78,645 (3.66)	74,594 (3.47)	4,051 (0.19)	379 (0.02)	3,672 (0.17)
	70~79세	12,104,203	34,573 (2.86)	31,986 (2.64)	2,587 (0.21)	367 (0.03)	2,220 (0.18)
	80세이상	6,306,646	12,668 (2.01)	11,124 (1.76)	1,544 (0.24)	440 (0.07)	1,104 (0.18)
백 신 별	아스트라제네카	20,348,860	109,900 (5.40)	104,182 (5.12)	5,718 (0.28)	449 (0.02)	5,269 (0.26)
	화이자	78,409,224	240,971 (3.07)	231,023 (2.95)	9,948 (0.13)	978 (0.01)	8,970 (0.11)
	모더나	24,622,395	111,723 (4.54)	109,143 (4.43)	2,580 (0.10)	245 (0.01)	2,335 (0.09)
	얀센	1,509,296	8,859 (5.87)	8,455 (5.60)	404 (0.27)	14 (0.01)	390 (0.26)
	노바백스	575,510	868 (1.51)	827 (1.44)	41 (0.07)	9 (0.02)	32 (0.06)
접종차수별	1차	44,827,739	240,086 (5.36)	229,763 (5.13)	10,323 (0.23)	605 (0.01)	9,718 (0.22)
	2차	42,891,091	174,954 (4.08)	169,107 (3.94)	5,847 (0.14)	613 (0.01)	5,234 (0.12)
	3차	33,302,193	54,549 (1.64)	52,206 (1.57)	2,343 (0.07)	433 (0.01)	1,910 (0.06)
	4차	4,444,262	2,732 (0.61)	2,554 (0.57)	178 (0.04)	44 (0.01)	134 (0.03)

- 코로나19 예방접종 이후 이상반응으로 의심되어 신고된 건으로 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 백신과 이상반응 간 인과성을 제시하는 것은 아님. 신고 현황 분류는 새로운 정보 추가시 변경 될 수 있음
- 일반 이상반응은 예방접종 이후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 흔하게 발생하는 증상을 포함
- 중대한 이상반응은 다음의 사례를 포함
 - 사망, ② 주요 이상반응 : 특별관심 이상반응(Adverse Event Special Interest, AESI), 중환자실 입원 생명위중, 영구장애/유유증 등
- 얀센 백신의 경우, 1회 접종만으로 기초접종(1차접종과 2차접종)이 완료되므로, 얀센 2차의 경우 3차 통계에 3차의 경우 4차 통계에 추가
- '21.2.26. 이후 누적 예방접종 건수로 국외기관 접종과 기타백신 접종 제외

※ 환자상태가 사망으로 변경된 573건을 포함한 전체 사망 누계는 2,268건(아스트라제네카 629건, 화이자 1,305건, 모더나 308건, 얀센 17건, 노바백스 9건)

3. 증상별 현황

□ 이상반응 증상별 의심사례 신고현황

[표 4. 이상반응 증상별 의심사례 신고현황]

- 이상반응 신고서의 기타 항목에 기입된 내용을 키워드 "탈모"로 검색해 산출한 결과로 이상반응 건수가 정확하지 않음
- 이상반응 신고서의 기타 항목에 기입된 내용을 키워드 "시력"으로 검색해 산출한 결과로 이상반응 건수가 정확하지 않음
- 이상반응 신고서의 "임신부 관련 이상반응" 항목에 기재한 경우를 기준으로 산출

[표 5. 코로나19 예방접종 이후 특별관심 이상반응(AESI) 신고율]

(단위: 건, 건/10만 건 접종)

구분		전체	코로나19 백신종류				
			아스트라제네카	화이자	모더나	얀센	노바백스
예방접종 (건)		125,465,285	20,348,860	78,409,224	24,622,395	1,509,296	575,510
이상반응 신고 (건)		472,321	109,900	240,971	111,723	8,859	868
특별관심 이상반응	급성 심혈관계 손상	2.00	1.91	2.09	1.85	1.86	0.70
	백신 관련 악화된 질병	1.88	3.53	1.61	1.32	2.98	0.70
	급성 호흡곤란 증후군	0.74	1.15	0.68	0.57	1.19	-
	응고장애	0.40	1.02	0.31	0.16	0.99	-
	길랭-바레 증후군	0.31	0.99	0.18	0.12	1.13	0.17
	혈소판감소증	0.28	0.77	0.18	0.19	0.60	-
	급성 신장 손상	0.18	0.32	0.17	0.12	0.07	-
	혈전증	0.18	0.57	0.10	0.11	0.27	0.17
	다형홍반	0.18	0.43	0.12	0.13	0.40	-
	급성 간장 손상	0.13	0.24	0.10	0.13	0.20	-
	후각 상실	0.10	0.17	0.09	0.09	0.27	0.17
	단일 장기 피부혈관염	0.09	0.29	0.05	0.05	0.20	-
	모세혈관 누출 증후군	0.06	0.15	0.04	0.05	-	-
	다기관 염증 증후군	0.05	0.09	0.05	0.03	0.20	0.17
	동상 유사 병변	0.04	0.14	0.02	0.02	0.13	-
	뇌수막염	0.03	0.02	0.03	0.02	0.07	-
	급성 무균성 관절염	0.02	0.08	0.01	0.02	-	0.17
	척수염	0.02	0.03	0.02	0.02	0.07	-

□ 이상반응 의심사례 증상 상위 10순위

- (전체) 코로나19 예방접종 이후 이상반응 증상별 의심사례 신고율(10만 건 접종)은 두통 89.1건, 근육통 86.1건, 어지러움 54.7건, 흉통 51.1건, 메스꺼움 42.8건 순으로 높음
- (연령대별) 19세이하는 흉통, 20세부터 49세까지는 두통, 50세부터 79세까지는 근육통, 80세이상은 어지러움의 신고율이 높았음

[표 6. 이상반응 의심사례 증상 상위 10순위 분포(연령대별)]

주) 3일내 접종부위 증상 = 3일내 접종부위 통증, 발적, 부기

○ **(백신종류별)** 아스트라제네카, 모더나, 노바백스 백신은 근육통, 화이자, 얀센 백신은 두통의 신고율이 높음

- (아스트라제네카) 근육통 155.0건, 두통 148.0건, 어지러움 93.4건 순
- (화이자) 두통 64.6건, 흉통 56.5건, 근육통 53.8건 순
- (모더나) 근육통 130.2건, 두통 113.3건, 발열 62.1건 순
- (얀센) 두통 193.9건, 근육통 136.1건, 어지러움 103.6건 순
- (노바백스) 근육통 30.9건, 두통 29.9건, 흉통 22.9건 순

[표 7. 이상반응 의심사례 증상 상위 10순위 분포(코로나19 백신종류별)]

(단위: 건(%), 건/10만 건 접종)

순위	전체	코로나19 백신종류				
		아스트라제네카	화이자	모더나	얀센	노바백스
예방접종	125,465,285	20,348,860	78,409,224	24,622,395	1,509,296	575,510
이상반응	472,321	109,900	240,971	111,723	8,859	868
1	두통 (23.7%, 89.1)	근육통 (28.7%, 155.0)	두통 (21.0%, 64.6)	근육통 (28.7%, 130.2)	두통 (33.0%, 193.9)	근육통 (20.5%, 30.9)
2	근육통 (22.9%, 86.1)	두통 (27.4%, 148.0)	흉통 (18.4%, 56.5)	두통 (25.0%, 113.3)	근육통 (23.2%, 136.1)	두통 (19.8%, 29.9)
3	어지러움 (14.5%, 54.7)	어지러움 (17.3%, 93.4)	근육통 (17.5%, 53.8)	발열 (13.7%, 62.1)	어지러움 (17.7%, 103.6)	흉통 (15.2%, 22.9)
4	흉통 (13.6%, 51.1)	발열 (12.8%, 69.0)	어지러움 (14.4%, 44.2)	흉통 (13.6%, 61.9)	알레르기반응 (11.4%, 67.1)	어지러움 (14.6%, 22.1)
5	메스꺼움 (11.4%, 42.8)	메스꺼움 (12.5%, 67.4)	메스꺼움 (11.0%, 33.8)	어지러움 (11.9%, 53.8)	메스꺼움 (11.0%, 64.7)	알레르기반응 (13.2%, 20.0)
6	발열 (9.5%, 35.6)	알레르기반응 (11.6%, 62.6)	알레르기반응 (8.5%, 26.1)	오한 (11.5%, 52.3)	발열 (10.2%, 59.9)	3일내 접종부위 증상 ^{주)} (11.3%, 17.0)
7	알레르기반응 (9.0%, 34.0)	오한 (11.2%, 60.4)	오한 (6.1%, 18.7)	메스꺼움 (11.1%, 50.4)	오한 (8.7%, 51.3)	메스꺼움 (9.1%, 13.7)
8	오한 (8.6%, 32.4)	3일내 접종부위 증상 ^{주)} (6.2%, 33.4)	발열 (6.0%, 18.4)	3일내 접종부위 증상 ^{주)} (7.6%, 34.5)	흉통 (6.9%, 40.3)	호흡곤란(숨이 참) (7.4%, 11.1)
9	3일내 접종부위 증상 ^{주)} (5.6%, 21.1)	구토 (5.4%, 29.3)	구토 (5.1%, 15.6)	알레르기반응 (7.5%, 34.0)	3일내 접종부위 증상 ^{주)} (4.9%, 29.0)	오한 (6.3%, 9.6)
10	구토 (5.0%, 19.0)	복통 (3.8%, 20.4)	3일내 접종부위 증상 ^{주)} (4.4%, 13.6)	구토 (4.7%, 21.2)	구토 (3.9%, 22.9)	발열 (5.4%, 8.2)

주) 3일내 접종부위 증상 = 3일내 접종부위 통증, 발적, 부기

○ 이상반응 의심사례 - 증상별 신고 10순위

[그림 2. 이상반응 의심사례 증상별 신고율 현황]

주) 3일내 접종부위 증상 = 3일내 접종부위 통증, 발적, 부기

4. 코로나19 예방접종 이후 이상반응 최초 증상발생까지 소요일

- 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 예방접종 이후 최초 증상발생일까지 소요 기간을 기준으로 산출
- (전체) 코로나19 예방접종 이후 이상반응 증상발생까지 평균 소요일은 4.93(4.90-4.96)일
 - (성별) 여자 4.64일, 남자 5.43일
 - (연령대별) 연령대가 높을수록 증상발생까지 소요일이 긴 경향을 보임
 - * 19세이하 3.67일, 20-29세 3.85일, 30-39세 4.40일, 40-49세 4.66일, 50-59세 5.10일, 60-69세 6.16일, 70-79세 6.54일, 80세이상 6.19일 순
 - (백신별) 아스트라제네카 5.62일, 얀센 5.51일, 화이자 4.95일, 모더나 4.17일, 노바백스 3.10일 순
 - (접종차수별) 2차 5.08일, 1차 4.92일, 3차 4.53일, 4차 3.56일 순

[표 8. 예방접종 이후 이상반응 증상발생까지 소요일 분포 I]

(단위: 건)

구분	예방접종 후 이상반응 증상발생까지 소요일						평균		분위수
	계	0일	1-3일	4-7일	8-30일	30일초과	Mean	(95% CI)	
전체	472,321	107,261	213,979	70,287	70,053	10,741	4.93	(4.90-4.96)	2 (1-5)
성별	남	170,265	33,033	79,031	26,277	27,334	4,590	5.43 (5.38-5.49)	2 (1-6)
	여	302,056	74,228	134,948	44,010	42,719	6,151	4.64 (4.61-4.68)	1 (1-5)
연령대별	19세이하	26,278	6,459	13,729	3,096	2,618	376	3.67 (3.56-3.78)	1 (1-3)
	20-29세	80,909	21,116	38,773	10,782	9,050	1,188	3.85 (3.79-3.91)	1 (0-4)
	30-39세	77,700	18,402	35,237	12,102	10,660	1,299	4.40 (4.34-4.47)	2 (1-5)
	40-49세	79,429	18,999	35,653	11,862	11,258	1,657	4.66 (4.59-4.73)	2 (1-5)
	50-59세	82,119	18,003	36,858	12,225	12,987	2,046	5.10 (5.03-5.17)	2 (1-6)
	60-69세	78,645	14,837	33,451	12,878	15,024	2,455	6.16 (6.07-6.25)	2 (1-7)
	70-79세	34,573	6,606	14,693	5,519	6,513	1,242	6.54 (6.39-6.70)	2 (1-7)
	80세이상	12,668	2,839	5,585	1,823	1,943	478	6.19 (5.92-6.46)	2 (1-6)
백신별	아스트라제네카	109,900	24,742	46,332	16,251	19,650	2,925	5.62 (5.54-5.69)	2 (1-6)
	화이자	240,971	53,815	111,361	36,323	33,721	5,751	4.95 (4.91-5.0)	2 (1-5)
	모더나	111,723	26,536	52,292	15,959	15,077	1,859	4.17 (4.11-4.22)	1 (1-5)
	얀센	8,859	1,898	3,578	1,659	1,530	194	5.51 (5.27-5.75)	2 (1-6)
	노바백스	868	270	416	95	75	12	3.10 (2.68-3.51)	1 (0-3)
접종차수별	1차	240,086	54,820	97,559	41,855	41,926	3,926	4.92 (4.89-4.96)	2 (1-6)
	2차	174,954	39,889	86,554	21,429	21,682	5,400	5.08 (5.02-5.14)	1 (1-4)
	3차	54,549	11,951	28,404	6,663	6,152	1,379	4.53 (4.44-4.61)	1 (1-4)
	4차	2,732	601	1,462	340	293	36	3.56 (3.33-3.80)	1 (1-3)

- (중증도별) 일반 이상반응은 증상발생까지 평균 4.71(4.68-4.74)일, 중대한 이상반응은 평균 10.24(9.96-10.52)일 소요

※ 의료기관 등에서 입력한 '이상반응 발생일시'를 기준으로 산출

[표 9. 예방접종 이후 이상반응 증상발생까지 소요일 분포 II]

(단위: 건)

III 특별 인구집단

1. 소아·청소년(5-18세)

□ 5세-11세

- (전체) 코로나19 예방접종 109,789건 중 91건 이상반응 신고(1,000건 접종시 0.83건)
- 백신 1,000건 접종시 일반이상반응 0.79건, 중대한 이상반응 0.04건 신고
- (성별) 남자 0.97건, 여자 0.69건

[표 10. 소아(5-11세) 이상반응 의심사례 신고 현황]

(단위: 건(건/1,000건 접종))

구 분	예방접종 ^o	이상반응 ^a					
		전체	일반 이상반응 ^b	중대한 이상반응 ^c			주요 이상반응
				소계	사망	주요 이상반응	
전체	109,789	91 (0.83)	87 (0.79)	4 (0.04)	0 (0.00)	4 (0.04)	
성별	남	55,898	54 (0.97)	53 (0.95)	1 (0.02)	0 (0.00)	1 (0.02)
	여	53,891	37 (0.69)	34 (0.63)	3 (0.06)	0 (0.00)	3 (0.06)
연령별	5세	4,298	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	6세	6,407	3 (0.47)	3 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	7세	8,254	10 (1.21)	8 (0.97)	2 (0.24)	0 (0.00)	2 (0.24)
	8세	10,752	7 (0.65)	7 (0.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	9세	15,282	8 (0.52)	8 (0.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	10세	20,447	13 (0.64)	13 (0.64)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	11세	44,349	49 (1.10)	47 (1.06)	2 (0.05)	0 (0.00)	2 (0.05)
접종차수	1차	69,885	66 (0.94)	63 (0.90)	3 (0.04)	0 (0.00)	3 (0.04)
	2차	39,904	25 (0.63)	24 (0.60)	1 (0.03)	0 (0.00)	1 (0.03)

- a. 코로나19 예방접종 이후 이상반응으로 의심되어 신고된 건으로 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 백신과 이상반응 간 인과성을 제시하는 것은 아님. 신고 현황 분류는 새로운 정보 추가시 변경 될 수 있음
- b. 일반 이상반응은 예방접종 이후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 흔하게 발생하는 증상을 포함
- c. 중대한 이상반응은 다음의 사례를 포함
① 사망, ② 주요 이상반응 : 특별관심 이상반응(Adverse Event Special Interest, AESI), 중환자실 입원 생명위중, 영구장애/후유증 등
- d. 안전 백신의 경우, 1회 접종만으로 기초접종(1차접종과 2차접종)이 완료되므로, 안전 2차의 경우 3차 통계에 3차의 경우 4차 통계에 추가
- e. '21.2.26. 이후 누적 예방접종 건수로 국외기관 접종과 기타백신 접종 제외

□ 12세-18세

- (전체) 코로나19 예방접종 이후 이상반응 의심사례 20,992건(1,000건 접종시 3.19건) 신고
- 백신 1,000건 접종시 일반 이상반응 3.10건, 중대한 이상반응 0.09건 신고
- (성별) 남자 3.02건, 여자 3.37건(남자의 1.1배)
- (연령별) 18세에서 4.12건으로 가장 많고, 17세 4.03건, 16세 3.67건 순으로 연령이 낮을수록 신고율 감소
- (접종차수별) 1차접종 2.89건, 2차접종 3.67건, 3차접종 2.67건으로 2차접종 이후 이상반응 신고율이 높았음

[표 11. 청소년(12-18세) 이상반응 의심사례 신고 현황]

- a. 코로나19 예방접종 이후 이상반응으로 의심되어 신고된 건으로 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 백신과 이상반응 간 인과성을 제시하는 것은 아님. 신고 현황 분류는 새로운 정보 추가시 변경 될 수 있음
- b. 일반 이상반응은 예방접종 이후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 흔하게 발생하는 증상을 포함
- c. 중대한 이상반응은 다음의 사례를 포함
① 사망, ② 주요 이상반응 : 특별관심 이상반응(Adverse Event Special Interest, AESI), 중환자실 입원 생명위중, 영구장애/후유증 등
- d. 안전 백신의 경우, 1회 접종만으로 기초접종(1차접종과 2차접종)이 완료되므로, 안전 2차의 경우 3차 통계에 3차의 경우 4차 통계에 추가
- e. '21.2.26. 이후 누적 예방접종 건수로 국외기관 접종과 기타백신 접종 제외

□ 소아청소년(5-18세) 증상별 이상반응 의심 신고현황

- (증상별) 코로나19 예방접종 이후 이상반응 증상별 의심사례 신고율(10만 건 접종)은 두통 79.4건, 홍통 61.4, 근육통 51.2건, 어지러움 42.7건, 발열 39.6건 순으로 높음
- 주요 이상반응 신고율은 급성심혈관계 손상(2.1건), 아나필락시스(2.1건), 경련(1.0건) 순

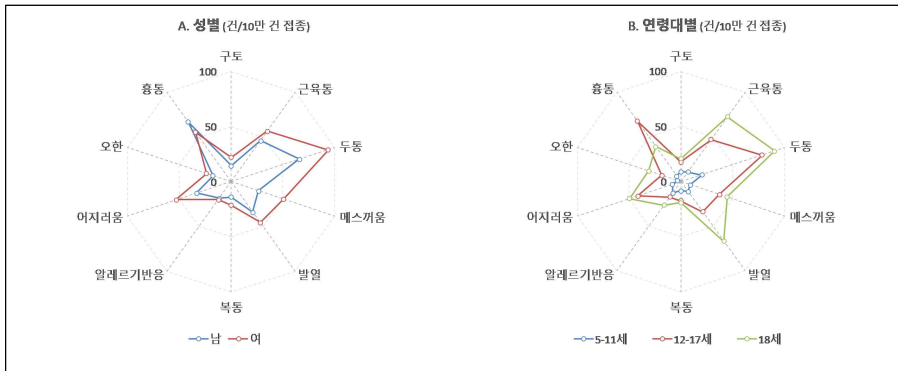
[표 12. 소아청소년(5-18세) 이상반응 종류별 신고현황]

(단위: 건/10만 건 접종)

순위	일반 이상반응		주요 이상반응	
	의심 증상	신고	의심 증상	신고
1	두통	5,309 (79.4)	급성 심혈관계 손상(심근염/심낭염)	142 (2.1)
2	홍통	4,106 (61.4)	아나필락시스(양반응 포함)	140 (2.1)
3	근육통	3,421 (51.2)	경련(경련/발작)	70 (1.0)
4	어지러움	2,853 (42.7)	백신 관련 악화된 질병	59 (0.9)
5	발열	2,646 (39.6)	급성마비	55 (0.8)
6	메스꺼움	2,549 (38.1)	급성 심혈관계 손상(기타)	31 (0.5)
7	오한	1,377 (20.6)	뇌증 혹은 뇌염	22 (0.3)
8	알레르기반응	1,276 (19.1)	급성 호흡곤란 증후군	21 (0.3)
9	구토	1,218 (18.2)	혈소판감소증	13 (0.2)
10	복통	1,166 (17.4)	혈소판 감소 자반증	11 (0.2)

※ (주의) 코로나19 예방접종 이후 이상반응으로 의심되어 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 신고된 의심증상의 진단 정확성 또는 백신과 이상반응 간 인과성을 제시하는 것은 아님

[그림 3. 소아청소년(5-18세) 이상반응 의심사례 증상별 신고율 현황]



- (연령구간별) 소아청소년의 이상반응 신고율(1,000건 접종)은 19세이상 신고율 대비 5-11세(0.83건)가 0.2배, 12-17세(2.97건)가 0.8배, 18세(4.12건)가 1.1배 수준

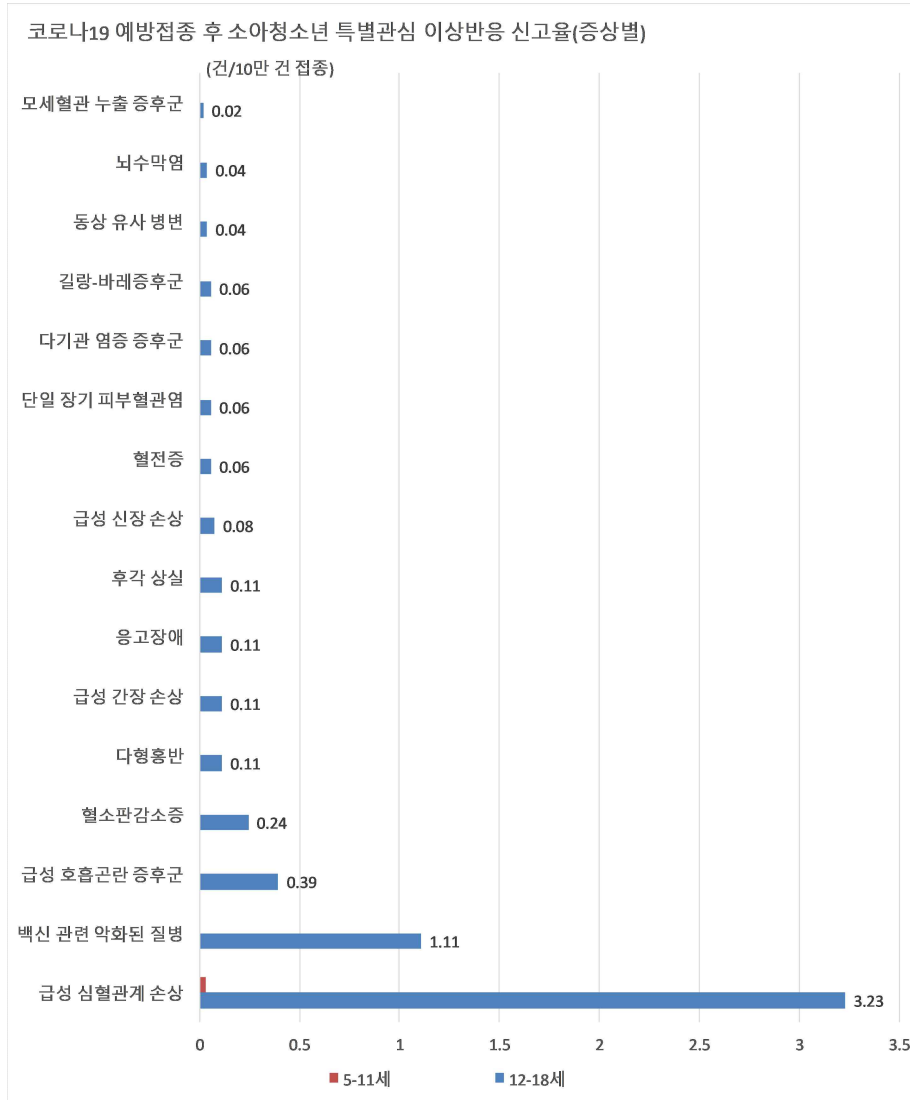
[표 13. 소아청소년(5-18세) 이상반응 의심사례 신고 현황]

- a. 코로나19 예방접종 이후 이상반응으로 의심되어 신고된 건으로 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 백신과 이상반응 간 인과성을 제시하는 것은 아님. 신고 현황 분류는 새로운 정보 추가시 변경 될 수 있음
- b. 일반 이상반응은 예방접종 이후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 흔하게 발생하는 증상을 포함
- c. 중대한 이상반응은 다음의 사례를 포함
① 사망, ② 주요 이상반응 : 특별관심 이상반응(Adverse Event Special Interest, AESI), 중환자실 입원 생명위중, 영구장애/후유증 등
- d. 안전 백신의 경우, 1회 접종만으로 기초접종(1차접종과 2차접종)이 완료되므로, 안전 2차의 경우 3차 통계에 3차의 경우 4차 통계에 추가
- e. '21.2.26. 이후 누적 예방접종 건수로 국외기관 접종과 기타백신 접종 제외

[그림 4. 소아청소년(5-18세)의 연령그룹별 이상반응 의심사례 신고율]

[그림 5. 소아·청소년의 코로나19 예방접종 후 특별관심 이상반응 신고율(증상별)]

(단위: 건/10만 건 접종)



2. 임신부

- (분석대상) '21.2.26.~'22.7.3. 동안 접종자 중, 출산예정일이 등록된 15~49세 연령 여성의 이상반응 신고 건을 대상으로 분석
- (신고현황) 총 50건의 이상반응 신고
 - 사망 1건, 주요이상반응 1건(백신관련 악화된 질병)

[표 14. 임신부의 이상반응 신고 현황]

- 코로나19 예방접종 이후 이상반응으로 의심되어 신고된 것으로 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 백신과 이상반응 간 인과성을 제시하는 것은 아님. 신고 현황 분류는 새로운 정보 추가시 변경 될 수 있음
- 일반 이상반응은 예방접종 이후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 흔하게 발생하는 증상을 포함
- 중대한 이상반응은 다음의 사례를 포함
 - ① 사망, ② 주요 이상반응 : 특별관심 이상반응(Adverse Event Special Interest, AESI), 중환자실 입원, 생명위중, 영구장애/후유증 등

○ 임신부 신고 이상반응의 세부 신고내역

[표 15. 임신부의 이상반응 증상별 빈도]

- 1) 이상반응 신고서 서식항목으로 체크된 내용, 2) 기타항목에 텍스트로 기술된 내용
- 3) '백신관련 악화된 질병'으로 이상반응을 신고한 1명이 텍스트에 '백신 접종 후 탈모가 급격히 진행' 기술
- 4) 임신부관련 이상반응은 자연유산 2건, 선천적 기형1건 신고

III 주요 특별관심 이상반응 의심사례 인과성 검토 결과(1~65차)

1. 아나필락시스(~7.1일)

○ 아나필락시스 의심사례 2,409건을 검토한 결과 인과성이 인정된 사례는 876건

* 876건 외에 1,533건은 아나필락시스의 가능성이 낮거나 판정이 불가한 사례임

[[표 16. 아나필락시스(아나필락시스 양반응 포함) 인과성 검토 결과]

(단위: 건)

백신명	연령	전체	남자							여자				
			1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
	계	876	696	137	42	1	204	39	13	1	492	98	29	-
아스트라제네카	합계	113	99	14	-	-	18	3	-	-	81	11	-	-
	19세 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20-29세	18	17	1	-	-	-	-	-	-	17	1	-	-
	30-39세	16	15	1	-	-	1	-	-	-	14	1	-	-
	40-49세	19	17	2	-	-	5	-	-	-	12	2	-	-
	50-59세	15	13	2	-	-	3	-	-	-	10	2	-	-
	60-69세	37	30	7	-	-	6	3	-	-	24	4	-	-
	70-79세	7	7	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-
80세 이상	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
화이자	합계	598	465	108	24	1	130	31	4	1	335	77	20	-
	19세 이하	73	56	13	4	-	27	6	-	-	29	7	4	-
	20-29세	189	153	31	5	-	42	10	1	-	111	21	4	-
	30-39세	123	96	22	5	-	23	4	1	-	73	18	4	-
	40-49세	124	96	24	4	-	22	5	1	-	74	19	3	-
	50-59세	62	48	9	5	-	10	2	1	-	38	7	4	-
	60-69세	3	2	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
	70-79세	9	5	2	1	1	1	1	-	1	4	1	1	-
80세 이상	15	9	6	-	-	4	3	-	-	5	3	-	-	
모더나	합계	129	100	14	15	-	36	4	8	-	64	10	7	-
	19세 이하	3	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	20-29세	46	40	3	3	-	21	-	-	-	19	3	3	-
	30-39세	29	22	4	3	-	6	1	3	-	16	3	-	-
	40-49세	29	23	4	2	-	6	3	1	-	17	1	1	-
	50-59세	15	11	3	1	-	2	-	1	-	9	3	-	-
	60-69세	4	1	-	3	-	-	-	2	-	1	-	1	-
	70-79세	3	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-
80세 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
얀센	합계	30	29	-	1	-	20	-	1	-	9	-	-	-
	19세 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20-29세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30-39세	19	18	-	1	-	16	-	1	-	2	-	-	-
	40-49세	9	9	-	-	-	4	-	-	-	5	-	-	-
	50-59세	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	60-69세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70-79세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80세 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
노바백스	합계	6	3	1	2	-	-	1	-	-	3	-	2	-
	19세 이하	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	20-29세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30-39세	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	40-49세	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	50-59세	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	60-69세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70-79세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80세 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 신고 후 변경된 사례를 포함하여 검토한 결과로 최초 신고 현황과는 차이가 있을 수 있음
잠정통계로 변동 가능하며, 판단근거 등 추가사항이 있을 시 재검토 할 수 있음

2. 심근염 및 심낭염(~6월 23일)

○ 총괄

- mRNA 백신 접종 이후 심근염/심낭염 발생 의심 사례를 1,680건의 진단 적합성을 검토하여 심근염/심낭염 사례가 714건(화이자 백신 503건, 모더나 백신 211건) 판정
- 바이러스백터 백신 접종 이후 심근염/심낭염 발생 의심 사례를 67건의 진단 적합성을 검토하여 심근염/심낭염 사례가 26건(아스트라제네카 백신 21건, 얀센 백신 5건) 판정
- 유전자재조합 백신 접종 이후 심근염/심낭염 발생 의심 사례를 2건의 진단 적합성을 검토하여 심근염/심낭염 사례가 2건(노바백스 백신 2건) 판정

○ 심근염

- (총괄) 심근염은 528건, 이 중 mRNA 백신 511건, 바이러스 백터 백신 15건, 유전자재조합 백신 2건임
- (성별) mRNA 백신 접종 이후 심근염 사례는 남자 338명, 여자 190명임
 - 화이자 백신 356건 중 남자는 230명, 여자는 126명임
 - 모더나 백신 155건 중 남자는 97명, 여자는 58명임
- (차수별) mRNA 백신의 접종 이후 심근염 사례는 1차접종 후 188건, 2차접종 이후 234건, 3차접종 이후 86건, 4차접종 이후 진단된 사례가 3건임
 - 화이자 백신 356건 중 1차접종 이후 127건, 2차접종 이후 165건, 3차접종 이후 61건, 4차접종 이후 3건
 - 모더나 백신 155건 중 1차접종 이후 61건, 2차접종 이후 69건, 3차접종 이후 25건
- (연령별) mRNA 백신의 경우 19세 이하부터 80세 이상까지 다양한 연령대에서 심근염 사례가 진단
 - 10대(147건), 20대(132건), 30대(82건), 50대(61건), 40대(60건), 60대(18건), 70대 이상(11건)

[표 17. 코로나19 예방접종 이후 신고된 심근염 진단 적합성 결과]

(단위: 건/접종10만건 당 발생률)

백신명	연령	접종	진단		전체											
					접종 차수						성별					
					1차		2차		3차		4차		남자		여자	
					건	율	건	율	건	율	건	율	건	율	건	율
	계	125,465,285	528	(0.4)	196	(0.4)	243	(0.6)	86	(0.3)	3	(0.1)	338	(0.5)	190	(0.3)
화이자	합계	78,409,224	356	(0.5)	127	(0.5)	165	(0.6)	61	(0.3)	3	(0.1)	230	(0.6)	126	(0.3)
	19세 이하	7,651,437	140	(1.8)	38	(1.1)	84	(2.6)	18	(1.7)	0	(0.0)	118	(3.0)	22	(0.6)
	20-29세	13,058,161	71	(0.5)	29	(0.6)	25	(0.5)	16	(0.5)	1	(12.5)	47	(0.7)	24	(0.4)
	30-39세	10,197,448	46	(0.5)	29	(0.8)	16	(0.4)	1	(0.0)	0	(0.0)	24	(0.5)	22	(0.4)
	40-49세	14,604,991	39	(0.3)	14	(0.3)	18	(0.3)	7	(0.2)	0	(0.0)	16	(0.2)	23	(0.3)
	50-59세	15,506,910	41	(0.3)	16	(0.3)	17	(0.3)	8	(0.2)	0	(0.0)	14	(0.2)	27	(0.3)
	60-69세	4,623,549	9	(0.2)	0	(0.0)	3	(0.5)	5	(0.2)	1	(0.1)	4	(0.2)	5	(0.2)
	70-79세	6,969,572	5	(0.1)	0	(0.0)	1	(0.1)	3	(0.1)	1	(0.1)	4	(0.1)	1	(0.0)
80세 이상	5,797,156	5	(0.1)	1	(0.1)	1	(0.1)	3	(0.2)	0	(0.0)	3	(0.1)	2	(0.1)	
모더나	합계	24,622,395	155	(0.6)	61	(0.9)	69	(1.0)	25	(0.2)	0	(0.0)	97	(0.7)	58	(0.5)
	19세 이하	324,908	7	(2.2)	2	(1.4)	4	(3.2)	1	(1.9)	0	(0.0)	6	(3.8)	1	(0.6)
	20-29세	3,486,107	61	(1.7)	17	(1.2)	42	(3.1)	2	(0.3)	0	(0.0)	46	(2.5)	15	(0.9)
	30-39세	3,847,105	36	(0.9)	17	(1.3)	14	(1.1)	5	(0.4)	0	(0.0)	23	(1.0)	13	(0.8)
	40-49세	4,629,070	21	(0.5)	11	(0.6)	7	(0.4)	3	(0.2)	0	(0.0)	9	(0.4)	12	(0.6)
	50-59세	6,066,702	20	(0.3)	13	(0.7)	2	(0.1)	5	(0.2)	0	(0.0)	6	(0.2)	14	(0.5)
	60-69세	4,694,028	9	(0.2)	1	(0.7)	0	(0.0)	8	(0.2)	0	(0.0)	6	(0.2)	3	(0.1)
	70-79세	1,526,051	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)
80세 이상	48,424	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
아스트라제네카	합계	20,348,860	12	(0.1)	3	(0.0)	9	(0.1)	0	(0.0)	0	-	8	(0.1)	4	(0.0)
	19세 이하	1,403	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	20-29세	310,864	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	30-39세	747,413	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	40-49세	1,220,648	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	50-59세	2,226,642	1	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	1	(0.1)
	60-69세	11,951,300	10	(0.1)	1	(0.0)	9	(0.2)	0	(0.0)	0	-	7	(0.1)	3	(0.0)
	70-79세	3,488,345	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
80세 이상	402,245	1	(0.2)	1	(0.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	1	(1.4)	0	(0.0)	
얀센	합계	1,509,296	3	(0.2)	3	(0.2)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.2)	1	(0.4)
	19세 이하	10	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	-	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	20-29세	45,044	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	30-39세	963,051	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	40-49세	282,864	3	(1.1)	3	(1.1)	0	-	0	(0.0)	0	-	2	(1.0)	1	(1.2)
	50-59세	129,344	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	60-69세	75,482	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	70-79세	10,536	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
80세 이상	2,965	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)	
노바백스	합계	575,510	2	(0.3)	2	(1.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.4)	1	(0.3)
	19세 이하	4,960	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	20-29세	37,237	1	(2.7)	1	(6.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(5.1)
	30-39세	73,722	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	40-49세	69,790	1	(1.4)	1	(3.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.9)	0	(0.0)
	50-59세	52,345	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	60-69세	171,901	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	70-79세	109,699	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
80세 이상	55,856	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	

※ 잠정통계로 변동가능, 판단근거가 명확한 추가사항이 있을 시 재평가 할 수 있음, 현재 접종

건수가 없는 경우 - 으로 표기

○ 심낭염

- (총괄) 심낭염 사례로 진단건은 214건, 이 중 mRNA 백신 203건, 바이러스 백신 11건임
- (성별) mRNA 백신 접종 이후 심낭염 사례는 남자는 115명, 여자는 88명임
 - 화이자 백신 147건 중 남자는 84명, 여자는 63명임
 - 모더나 백신 56건 중 남자는 31명, 여자는 25명임
- (차수별) mRNA 백신의 접종 이후 심낭염 사례로 진단된 203건 중 1차접종 이후 83건, 2차접종 이후 91건, 3차접종 이후 27건, 4차접종 이후 진단된 사례가 2건임
 - 화이자 백신 147건 중 1차접종 이후 53건, 2차접종 이후 70건, 3차접종 이후 22건, 4차접종 이후 2건
 - 모더나 백신 56건 중 1차접종 이후 30건, 2차접종 이후 21건, 3차접종 이후 5건
- (연령별) mRNA 백신의 경우 19세 이하부터 80세 이상까지 다양한 연령대에서 심낭염 사례가 진단
 - 20대(53건), 30대(49건), 40대(33건), 10대(30건), 50대(28건), 60대(5건), 70대 이상(5건)

[표 18. 코로나19 예방접종 이후 신고된 심낭염 진단 적합성 결과]

(단위: 건/접종10만건 당 발생률)

백신명	연령	접종	진단		전체								성별			
					접종 차수								남자		여자	
			건	율	건	율	건	율	건	율	건	율	건	율	건	율
	계	125,465,285	214	(0.2)	88	(0.2)	97	(0.2)	27	(0.1)	2	(0.0)	123	(0.2)	91	(0.1)
화이자	합계	78,409,224	147	(0.2)	53	(0.2)	70	(0.3)	22	(0.1)	2	(0.1)	84	(0.2)	63	(0.2)
	19세 이하	7,651,437	28	(0.4)	7	(0.2)	16	(0.5)	5	(0.5)	0	(0.0)	19	(0.5)	9	(0.2)
	20~29세	13,058,161	37	(0.3)	14	(0.3)	19	(0.4)	4	(0.1)	0	(0.0)	21	(0.3)	16	(0.3)
	30~39세	10,197,448	33	(0.3)	16	(0.4)	15	(0.4)	2	(0.1)	0	(0.0)	15	(0.3)	18	(0.3)
	40~49세	14,604,991	22	(0.2)	7	(0.1)	9	(0.2)	6	(0.1)	0	(0.0)	10	(0.1)	12	(0.2)
	50~59세	15,506,910	18	(0.1)	9	(0.2)	7	(0.1)	2	(0.0)	0	(0.0)	14	(0.2)	4	(0.1)
	60~69세	4,623,549	4	(0.1)	0	(0.0)	1	(0.2)	2	(0.1)	1	(0.1)	3	(0.1)	1	(0.0)
	70~79세	6,969,572	3	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	1	(0.0)	1	(0.1)	1	(0.0)	2	(0.1)
	80세 이상	5,797,156	2	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)	1	(0.0)
모더나	합계	24,622,395	56	(0.2)	30	(0.4)	21	(0.3)	5	(0.0)	0	(0.0)	31	(0.2)	25	(0.2)
	19세 이하	324,908	2	(0.6)	1	(0.7)	1	(0.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(1.3)	0	(0.0)
	20~29세	3,486,107	16	(0.5)	7	(0.5)	8	(0.6)	1	(0.1)	0	(0.0)	10	(0.5)	6	(0.4)
	30~39세	3,847,105	16	(0.4)	11	(0.9)	5	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	11	(0.5)	5	(0.3)
	40~49세	4,629,070	11	(0.2)	7	(0.4)	3	(0.2)	1	(0.1)	0	(0.0)	3	(0.1)	8	(0.4)
	50~59세	6,066,702	10	(0.2)	4	(0.2)	4	(0.2)	2	(0.1)	0	(0.0)	4	(0.1)	6	(0.2)
	60~69세	4,694,028	1	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)	0	(0.0)
	70~79세	1,526,051	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	80세 이상	48,424	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
아스트라제네카	합계	20,348,860	9	(0.0)	3	(0.0)	6	(0.1)	0	(0.0)	0	-	6	(0.1)	3	(0.0)
	19세 이하	1,403	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	20~29세	310,864	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	30~39세	747,413	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	40~49세	1,220,648	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	50~59세	2,226,642	1	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	-	1	(0.1)	0	(0.0)
	60~69세	11,951,300	6	(0.1)	2	(0.0)	4	(0.1)	0	(0.0)	0	-	3	(0.1)	3	(0.0)
	70~79세	3,488,345	2	(0.1)	1	(0.1)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	-	2	(0.1)	0	(0.0)
	80세 이상	402,245	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
얀센	합계	1,509,296	2	(0.1)	2	(0.1)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.2)	0	(0.0)
	19세 이하	10	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	-	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	20~29세	45,044	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
	30~39세	963,051	1	(0.1)	1	(0.1)	0	-	0	(0.0)	0	-	1	(0.1)	0	(0.0)
	40~49세	282,864	1	(0.4)	1	(0.4)	0	-	0	(0.0)	0	-	1	(0.5)	0	(0.0)
	50~59세	129,344	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	60~69세	75,482	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	70~79세	10,536	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	80세 이상	2,965	0	(0.0)	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	-	0	(0.0)	0	(0.0)
노바백스	합계	575,510	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	19세 이하	4,960	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	20~29세	37,237	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	30~39세	73,722	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	40~49세	69,790	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	50~59세	52,345	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	60~69세	171,901	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	70~79세	109,699	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	80세 이상	55,856	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

※ 잠정통계로 변동가능, 판단근거가 명확한 추가사항이 있을 시 재평가 할 수 있음, 현재 접종 건수가 없는 경우 - 으로 표기

3. 혈소판감소성 혈전증(~6월 24일)

○ 신고된 의심사례 213건 중 인과성이 인정된 사례는 4건

- (백신별) 아스트라제네카 백신 1차접종자가 3건, 2차접종자가 1건
- (성별/연령별/발생부위) 30대 남자 2명(뇌정맥), 70대 여자 1명(심부정맥), 60대 남자 1명(폐동맥)

4. 길랭-바레 증후군(~6월 24일)

○ 신고된 의심사례 101건을 검토한 결과 인과성 불충분(④-1) 사례는 22건

- (성별) 남자 15건, 여자 7건
- (연령별) 20대 1건, 30대 3건, 40대 2건, 50대 1건, 60대 13건, 70대 2건
- (백신별) 아스트라제네카 20건(1차: 16건, 2차 4건), 얀센 2건

5. 중증 및 사망 사례

□ 중증사례 일반적 특성

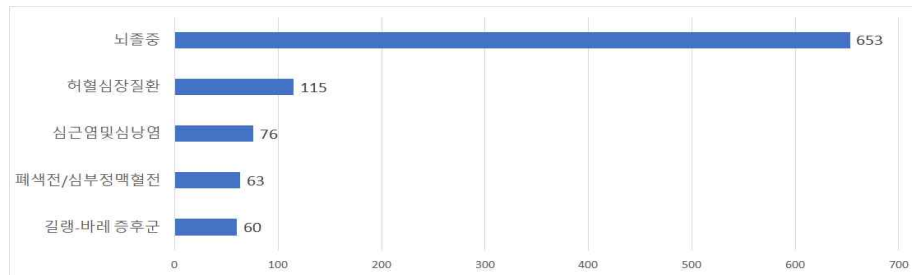
[표 19. 이상반응 중증사례 일반적 특성]

(단위: 건)

구 분	계		백신 종류									
	N	%	아스트라제네카	화이자	아스트라제네카·화이자	얀센	모더나	얀센·모더나	아스트라제네카·모더나	노바백스	화이자·노바백스	시노팜·화이자
계	1757	100.0	604	884	54	22	132	8	49	2	1	1
성별												
남성	986	56.1	342	472	32	19	83	7	31			
여성	771	43.9	262	412	22	3	49	1	18	2	1	1
연령대												
10대	51	2.9		47			4					
20대	76	4.3	13	45		1	17					
30대	92	5.2	14	41	4	16	12	5				
40대	152	8.7	23	77	15	2	34	1				
50대	249	14.2	52	134	8	2	50	2	1			
60대	396	22.5	305	33	15		9		33			1
70대	407	23.2	164	210	9	1	6		15	1	1	
80대 이상	334	19.0	33	297	3					1		
기저질환												
유	1365	77.7	506	682	41	11	78	4	40	1	1	1
무	392	22.3	98	202	13	11	54	4	9	1		
접종 후 증상발생 기간												
<1일	340	19.4	95	187	10	6	26	3	11	1	1	
1일	208	11.8	75	95	10	2	15	1	9	1		
2일	158	9.0	43	95	5		13		2			
≥3일	1051	59.8	391	507	29	14	78	4	27			1

□ 중증사례 추정진단명(다빈도)

[그림 6. 이상반응 중증사례 추정진단명]



* 피해조사반 검토 중증사례의 추정진단명 상위 5개 분포(추가조사 결과에 따라 일부 변경가능)

□ 사망사례 일반적 특성

[표 20. 이상반응 사망사례 일반적 특성]

□ 사망사례 추정사인(다빈도)

[그림 7. 이상반응 사망사례 추정사인]

* 피해조사반 검토 사망사례의 추정사인 상위 5개 분포(부검 최종결과에 따라 일부 변경 가능)

붙임 2 국외 코로나19 예방접종 이후 이상반응 보고현황(70주차)

□ 총괄표

국가	접종 현황 (건)	이상반응 (건)	중증 (건)	아나필락시스 (건)	사망 (건)	보고일 (접종기간)	출처	
영국	화이자(P)	8,190만	171,590	-	666	794	2022.6.24. (P: 20.12.9-22.6.15 A: 21.1.4-22.6.15 M: 21.1.19-22.6.15)	Summary of yellow card reporting, Medicines & Healthcare products Regulatory Agency(MHRA)
	아스트라제네카(A)	4,905.8만	245,614	-	885	1,287		
	모더나(M)	1,250만	39,514	-	93	62		
	모름	-	1,745	-	-	48		
	계	14,345.8만	458,463	-	1,644	2,191		
독일	화이자(P)	126,122,124	-	-	-	-	2022.5.4. (P: 20.12.27-22.3.31. M: 21.1.6-22.3.31. A: 21.1.30-22.3.31. J: 21.3.11-22.3.31 N: 22.2.28-3.31.)	Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
	모더나(M)	29,422,760	-	-	-	-		
	아스트라제네카(A)	12,732,656	-	-	-	-		
	얀센(J)	3,613,321	-	-	-	-		
	노바백스(N)	172,063	-	-	-	-		
노르웨이	계	172,062,925	296,233	-	-	2,810	2022.6.16. (P: 20.12.27-22.6.14 M: 21.1.15-22.6.14 A: 21.2.8-22.6.14 J: 21.6.51-22.6.14 N: 22.3.8-6.14)	Reported suspected adverse reactions to coronavirus vaccines (Norway Medicines Agency)
	화이자(P)	8,930,638	21,744	4,181	-	236		
	모더나(M)	2,285,819	8,075	1,383	-	18		
	아스트라제네카(A)	147,728	9,105	746	-	6		
	얀센(J)	7,299	37	4	-	0		
캐나다	노바백스(N)	811	0	0	-	0	2022.6.27. (P: 20.12.14-22.5.27. M: 20.12.24-22.5.27. A: 21.3.-22.5.27. J: 21.11.23-22.5.27. N: 22.17-5.27)	Government of Canada
	계	11,372,295	38,961	6,314	-	260		
	화이자(P)	57,487,001	27,766	6,634	-	-		
	모더나(M)	23,964,126	14,573	1,866	-	-		
	코비실드(A)	2,813,048	3,983	903	-	-		
오스트리아	얀센(J)	21,394	57	21	-	-	2022.6.30. (P: 20.12.21-22.6.24 M: 21.1.29-22.6.24 A: 21.1.6-22.6.24 J: 21.3.11-22.6.24 N: 22.2.26-22.6.24)	Bericht BASG Nebenwirkungsmeldungen
	노바백스(N)	-	2	1	-	-		
	모름	-	358	303	-	-		
	계	85,133,726	46,739	9,728	-	345		
	화이자(P)	14,838,360	25,205	1,882	-	220		
프랑스	모더나(M)	1,595,908	4,975	265	-	26	2022.6.30. (P: 20.12.27-22.6.16 M: 21.1.22-22.6.16 A: 21.2.6-22.6.16 J: 21.4.24-22.6.16 N: 22.3.1-6.16)	ANSM-Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
	아스트라제네카(A)	1,589,157	19,130	414	-	36		
	얀센(J)	364,912	1,423	82	-	4		
	노바백스(N)	10,127	34	1	-	0		
	계	18,398,464	50,767	2,644	-	286		
덴마크	화이자(P)	112,211,700	109,329	-	-	-	2022.6.30. (P: 20.12.27-22.6.16 M: 21.1.22-22.6.16 A: 21.2.6-22.6.16 J: 21.4.24-22.6.16 N: 22.3.1-6.16)	ANSM-Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
	모더나(M)	23,709,110	28,562	-	-	-		
	아스트라제네카(A)	7,859,600	30,012	-	-	-		
	얀센(J)	1,087,600	1,609	-	-	-		
	노바백스(N)	22,300	45	-	-	-		
호주	계	145,178,000	169,557	-	-	-	2022.6.30. (P: 20.12.27-22.6.16 M: 21.1.22-22.6.16 A: 21.2.6-22.6.16 J: 21.4.24-22.6.16 N: 22.3.1-6.16)	ANSM-Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
	화이자(P)	11,567,188	35,477	-	-	135		
	모더나(M)	1,832,950	8,960	-	-	20		
	아스트라제네카(A)	159,662	23,963	-	-	4		
	얀센(J)	50,917	512	-	-	1		
일본	모름	-	86	-	-	-	2022.6.25. (P: 20.12.21-22.6.21. M: 21.1.6-22.6.21. A: 21.1.29-22.6.21. J: -22.6.21.)	Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vaccine
	계	13,610,717	68,998	-	-	160		
	화이자(P)	4,160만	78,161	-	-	-		
	모더나(M)	460만	6,722	-	-	-		
	아스트라제네카(A)	1,380만	48,187	-	-	-		
호주	노바백스(N)	160,000	791	-	-	-	2022.6.30. (P: 21.2.22-22.6.26 M: 21.9.18-22.6.26 A: 21.2.22-22.6.26 N: 22.2.21-22.6.26)	Therapeutic Goods Administration
	모름	-	650	-	-	-		
	계	60,169,217	133,374	-	-	890		
	화이자(P)	213,442,888	28,843	6,294	2,734	1,202		
	모더나(M)	63,223,453	4,928	982	491	122		
일본	아스트라제네카(A)	117,161	16	11	6	0	2022.6.10. (P: 21.2.17-22.5.15. M: 21.5.10-22.5.15. A: 21.8.2-22.5.15)	후생성, 예방접종 이상반응 검토위원회
	계	276,783,502	33,787	7,287	3,231	1,324		

* 1) 영국: 아나필락시스 건수는 아나필락시스와 아나필락시스 양 반응 모두 포함, 2)노르웨이는 평가 완료된 보고사례기준, 3) 오스트리아 중증 환자는 입원환자임 ** 국가별 자료수집 방법이 달라, 단순비교는 어려움

□ 주요 내용

붙임 4 감염병 보도준칙 (2020.4.28.)

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.
추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 과장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도

가. 발생 원인이나 감염경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리청을 포함한 보건당국에 사실 여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문의자의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
“국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’ … 중동의 공포 465명 사망!”
“‘해외여행 예약 0건’…여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용
“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”
“온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”
“‘코로나19’에 박살난 지역경제…‘공기업 역할해라’”
다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교



“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리던 사망위험 커”
“전파력 메르스 ‘1000배’ ...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다 .
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일
한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회